

Clínica Psicológica



Vera Balance

INFORME PSICOLÓGICO CLÍNICO

CONSTANCIA DE ALTA TERAPÉUTICA

Psicóloga Monica Vera Ensico

17 de Diciembre de 2025

Cédula Profesional 14020223

Datos de identificación

Nombre de la paciente: Astrid Estephanya Juárez Martínez

Edad: 6 años

Madre: Cynthia Mariana Juárez Martínez

Kinder: Jardín de niños León Felipe

Primaria: Aguatín González Plata

El presente informe tiene como finalidad documentar de manera formal y detallada el proceso de intervención psicológica, los avances observados y el cumplimiento de objetivos terapéuticos, con el propósito de emitir constancia de alta terapéutica de la paciente. Este reporte se elabora a solicitud de la madre, principalmente para fines de seguimiento escolar, familiar y para dejar constancia el estado actual de la paciente y recomendaciones preventivas para mantener los avances.

Al tratarse de una paciente menor de edad, la información fue obtenida mediante entrevista con la madre, observación clínica durante las sesiones, y retroalimentación escolar considerando siempre el bienestar integral de la menor y el respeto a su etapa del desarrollo.

Contexto de canalización

Astrid fue canalizada por el Jardín de niños León Felipe aproximadamente en junio de 2025 debido a conductas reportadas como problemáticas dentro del entorno escolar y que también se presentaban en casa, las cuales impactaban su convivencia y desempeño. En el contexto escolar (kinder, al momento de la canalización) se reportó un patrón conductual consistente con dificultades en autorregulación, incluyendo conductas agresivas hacia pares (golpear compañeros), baja respuesta a indicaciones, aumento de inquietud motora (levantarse de su lugar con frecuencia) e interferencia en la dinámica grupal asociada a dificultad para regular impulsos.

En el contexto familiar, durante entrevista, la madre describió dificultades para seguir instrucciones en actividades cotidianas, gritos frecuentes como forma de expresión ante frustración o límites, inquietud durante la comida (no permanecer sentada, levantarse repetidamente) y manifestaciones conductuales relacionadas con tensión (morder uñas y rascarse de forma recurrente).

Objetivos terapéuticos:

A partir del motivo de consulta y reportes iniciales, se establecieron objetivos generales: disminuir conductas agresivas y mejorar convivencia con pares; fortalecer autorregulación emocional (manejo de frustración y expresión adecuada); incrementar atención sostenida y permanencia en actividad (especialmente en tareas dirigidas); mejorar seguimiento de instrucciones y respuesta a límites; reducir manifestaciones asociadas a tensión (morder uñas, rascado) y conductas desorganizadas (gritos frecuentes e inquietud).

Metodología e instrumentos

La intervención se realizó con frecuencia de 1 sesión semanal. La asistencia fue regular y constante durante el proceso, sin faltas reportadas.

Durante el proceso terapéutico se utilizaron estrategias acordes a la edad, priorizando técnicas vivenciales y psicoeducativas. Se empleó un cuaderno de apoyo terapéutico como herramienta de seguimiento semanal (registro de avances, tareas y actividades de acorde a su edad), entrenamiento de habilidades (atención, normas, expresión emocional), mediante trabajos para practicar en casa con guía simple para la madre, y refuerzo positivo a través del registro visual de logros. Se trabajó con terapia de juego como medio clínico principal para facilitar expresión emocional y comprensión de situaciones, modelar conductas esperadas (turnos, reglas, tolerancia a perder), reforzar autocontrol mediante pausas, elección de opciones y regulación, observar patrones (frustración, impulsividad, respuesta a límites y atención sostenida), y desarrollar habilidades sociales adaptativas sin confrontación directa. Se integraron libros y cuentos terapéuticos para psicoeducación emocional (identificar emociones, nombrarlas y expresarlas), elaboración de experiencias mediante metáforas adecuadas a su edad, promover empatía y toma de perspectiva, y entrenar secuencias "pienso-siento-hago" de forma concreta. Se utilizaron videos de apoyo con fines de refuerzo de aprendizajes (normas, calma, manejo de enojo), atención guiada breve para aumentar tolerancia a actividad estructurada, y facilitación del lenguaje emocional y conductual. Adicionalmente, se incorporaron técnicas de respiración como recurso de autorregulación, orientadas a disminuir activación emocional, favorecer la pausa antes de responder y acompañar el manejo de frustración mediante ejercicios breves y adaptados a su edad.

Descripción del estado psicológico actual y conclusiones

Con base en observación clínica, reporte materno y retroalimentación escolar, al momento del cierre no presenta conductas agresivas actuales y muestra mejor adaptación grupal.

En el área de atención, permanencia y desempeño escolar y familiar, la madre reporta que Astrid permanece en su lugar, en su último reporte escolar presenta buenas calificaciones, lo cual sugiere un impacto positivo en su desempeño. En casa, la madre refiere disminución marcada de gritos y mejor respuesta a indicaciones; reporta que Astrid mantiene mayor permanencia durante actividades como comer, hacer tarea o ver películas, reduciendo levantarse constantemente, y se observa mejor aceptación de tiempos y acuerdos. En indicadores relacionados con tensión, se reporta disminución significativa del mordido de uñas y del rascado, considerando que su nivel de ansiedad disminuyó de manera notable, reflejándose en conductas más organizadas y menor reactividad.

Como conclusión, la paciente mostró mejoría sostenida y clínicamente significativa en los principales indicadores que motivaron la canalización: agresividad, inquietud, baja permanencia, gritos y dificultades atencionales funcionales. El proceso permitió desarrollar habilidades de autorregulación, manejo de límites, adaptación escolar y fortalecimiento de recursos emocionales acordes a su etapa. Con la información disponible, y considerando la evolución positiva, no se identifican datos actuales que sugieran la presencia de un trastorno del neurodesarrollo o una condición que limite su aprendizaje o socialización, especialmente dado que los indicadores conductuales disminuyeron significativamente con intervención, estructura y acompañamiento. Se resalta que el entorno es un factor clave: la consistencia en límites, rutina y refuerzo positivo se asocia directamente con la estabilidad alcanzada. El desarrollo infantil no es lineal; pueden presentarse conductas propias de la edad en periodos de cambio (inicio de primaria, ajustes familiares, cansancio etc) en esta etapa es esperable cierta variabilidad en atención, impulsividad y manejo emocional; sin embargo, cuando estas conductas son frecuentes, intensas o interfieren significativamente con el desempeño escolar y la convivencia se recomienda aplicar estrategias aprendidas para fortalecer habilidades de autorregulación, normas, límites, atención sostenida y recursos emocionales y si hubiera retrocesos persistentes, solicitar apoyo profesional.

Con base en el cumplimiento de objetivos terapéuticos, la estabilidad conductual reportada en casa y escuela, la mejora observada en autorregulación y desempeño, se otorga ALTA TERAPÉUTICA a Astrid Estephanya Juárez Martínez, concluyendo su proceso de intervención psicológica en "Vera Balance" El alta se emite por logro de objetivos y evolución favorable, quedando abierta la posibilidad de sesiones de seguimiento preventivo si se considera necesario.

Recomendaciones terapéuticas

Se sugiere mantener la práctica de las actividades trabajadas en terapia y cuaderno de actividades, especialmente aquellas orientadas a atención breve sostenida, cumplimiento de instrucciones (en pasos simples) y manejo de frustración (pausas, respiración, opciones de apoyo) con el objetivo de consolidar los avances y prevenir recaídas conductuales. Se recomienda establecer una rutina diaria consistente con horarios claros para sueño, higiene, comida, tarea, juego y tiempo de pantalla, idealmente con apoyo visual (tabla con dibujos), favoreciendo previsibilidad y disminución de reactividad emocional, pero permitiendo que poco a poco ella realice esas actividades por sí sola. Asimismo, se sugiere implementar juegos de mesa en familia 2-4 veces por semana para entrenar de forma natural respeto a turnos, tolerancia a perder/esperar, seguimiento de reglas, autocontrol e inhibición de impulsos, reforzando el esfuerzo y la conducta más que el resultado. Se recomienda utilizar refuerzo positivo inmediato y específico cuando cumpla acuerdos; en caso de conductas inadecuadas, aplicar consecuencias breves, claras y consistentes, evitando discusiones largas. Finalmente, se deja cita abierta para apoyo preventivo o en caso de presentarse nuevamente conductas que interfiera con el desempeño escolar o la convivencia.

Psic. Monica Vera
Céd. Prof. 14020223